

Bipolar I, II und Mischbilder verstehen

Die Begriffe klingen technisch, beschreiben aber eine häufige Verwirrung: Wie stark ist die Hochphase? Wie belastend sind Tiefphasen? Und können Tempo, Unruhe und Verzweiflung gleichzeitig auftreten? Dieses Blatt ersetzt keine fachliche Abklärung, Diagnose oder Behandlung.

WORUM ES GEHT

Angehörige sehen meist keine Diagnosekriterien, sondern Alltag: wenig Schlaf, mehr Tempo, Rückzug, Gereiztheit, Risikoverhalten, Scham oder Verzweiflung. Die Begriffe Bipolar I, Bipolar II und Mischbilder helfen, solche Muster vorsichtiger einzuordnen.

Bipolar I, Bipolar II und Mischbilder sind keine Rangliste von «leicht» bis «schwer». Entscheidend ist, welche Muster zusammenkommen: Schlaf, Tempo, Stimmung, Risiko, Rückzug, Verzweiflung — und wie stark sie Alltag, Beziehung und Sicherheit verändern.

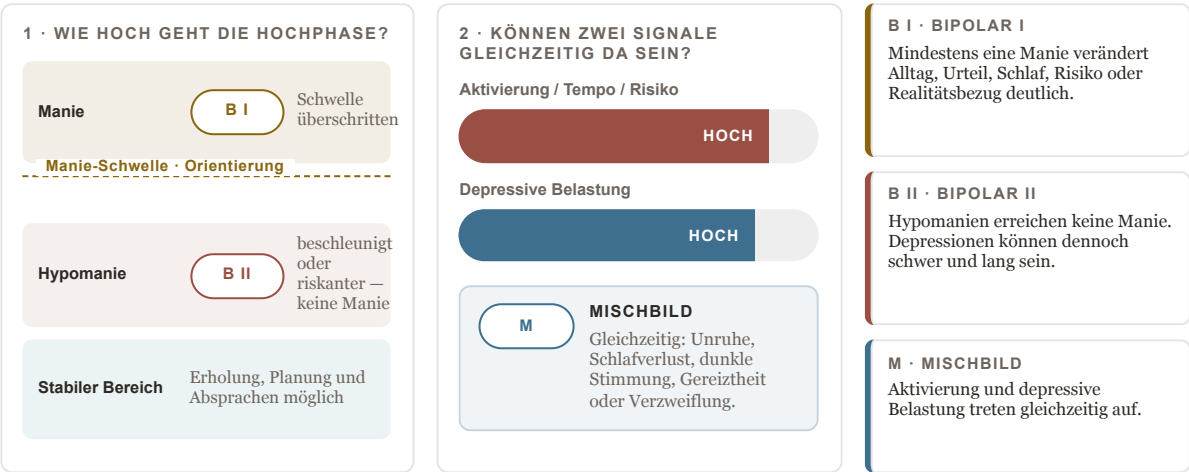
DREI UNTERSCHIEDUNGEN

- **Bipolar I:** Mindestens eine Manie verändert Alltag, Urteil, Schlaf, Risiko oder Realitätsbezug deutlich.
- **Bipolar II:** Hypomanien erreichen keine Manie. Depressive Episoden können trotzdem schwer, lang und alltagsprägend sein.
- **Mischbild:** Aktivierung und depressive Belastung treten gleichzeitig auf: Unruhe, Schlafverlust, dunkle Stimmung, Gereiztheit oder Verzweiflung.

ENTLASTENDER KERNSATZ

Weniger sichtbar bedeutet nicht weniger ernst. Für Angehörige zählt zuerst: Was verändert sich, was kommt zusammen, wie lange hält es an — und braucht es Unterstützung?

SCHWELLE UND MISCHBILD · DREI DINGE GETRENNT SEHEN



vereinfachtes Modell — keine diagnostische Einordnung

NICHT DIAGNOSTIZIEREN

Die Begriffe helfen beim Sortieren. Ob Kriterien erfüllt sind, gehört in die fachliche Abklärung.

NICHT VERHARMLOSEN

Weniger sichtbare Hochphasen können täuschen, besonders wenn depressive Phasen dominieren.

KONKRETER NÄCHSTER SCHRITT

Bei einer verwirrenden Veränderung getrennt notieren: Schlaf, Tempo, Stimmung, Risiko und Rückzug. So wird sichtbarer, ob mehrere Muster gleichzeitig kippen.